EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 94825
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-10-14 16:50:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: HECTOR PASCUAL BELTRAN VALDEBENITO			RUN	: 6.831.554-9
F.Nac	: 28-12-1951	Edad	: 72 AÑOS, 9 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 09-10-2024	Fecha Egreso	: 2024-10-14 16:50:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I61-HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-HIC temporal lateral izquierda, etiología en estudio, obs amiloidea vs 2° TACO, ICH 1, 9° día
-Obs neumopatía aguda infecciosa, ATB 3/7
-ANt: HTA - DM2 IR - ERC en HD trisemanal - Amputación hallux derecho - EAOC EEII - Baja visión bilateral

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I61.4-HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA EN CEREBRO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente BEG, HDN con HTA moderada, RS al monitor, eupneico, afebril, impresiona sin dolor y tranquilo, mejor en lo neurológico (impresiona menor disartria, mejor comprensión del lenguaje verbal y conexión con el medio, mantiene vigilia espontáneamente), tolera bien alimentación VO y marcha con andador asistido con 1 operador.
HIC de aspecto heterogeneo, bordes irregulares, swirl sign(+), sin cambios entre TC cerebro de ingreso y angioTC cerebro, sin signos de herniacion cerebral ni HV, edema perilesional leve, aprox 40 cc (3.8*5*4 cm).
AngioTC cerebro y cuello: estenosis no significativa origen M2 posterior derecha, estenosis 50% de P2 izquierda distal y P3 izquierda proximal, sin lesiones sugerentes de malformación AV
Urocultivo resulto negativo, se suspendió ATB.
En exs de control destaca PCR en descenso, sin leucocitosis, Na 123. En exs de lab ulteriores, posterior a suspensión de FSD y corrección con HCO3, se logró Na 133 en >48h.
TC cerebro s/c de control seriados muestran estabilidad de volumen de HIC, sin signos de herniacion cerebral y discreto edema vasogénico sin efecto de masa.
Diuresis(+) dep(+)
Durante fin de semana presentó tos productiva intermitente, sin compromiso ventilatorio ni HD, afebril, se inició ceftriaxona 2g/d (hoy 3° día), TC tórax muestra posible neumopatía aguda infecciosa; asociado a ascenso moderado de PCR.
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio el 15/10/24, continuar ATB EV para completar 7 días, mantener KNTM y rehabilitación fonoaudiológica en en HODOM, mantener HD trisemanal, no usar antitrombóticos por al menos 30 días, y control en policlínico de Neurología en 10-15 días.

PLAN DE MANEJO:

-HD trisemanal lunes-miércoles-viernes
-Alta a domicilio mañana martes 15/10/24
-Control en policlínico de Neurología en 10-15 días

INDICACIONES AL ALTA

1. -Amlodipino 10 mg/día
2. -Isosorbide 10 mg c/8 horas
3. -Hidralazina 50 mg c/6 horas
4. -Metildopa 250 mg 2 comp c/8 horas
5. -Carvedilol 6.25 mg 1/2 comp c/12 horas
6. -Ipratropio 2 puff c/6 horas por 5-7 días
7. -Ceftriaxona 2g/día EV por 4 días

EXÁMENES Y RESULTADOS

12/10/24
-PCR 82.9
-Na 133 K 5.1 Cl 95

11/10/24
-Na 130 K 5.4 Cl 89

10/10/24
-Alb 3.5
-Crea 7.5 MDRD 7.18
-AU 3.3
-Ca 8.4 P 4.2 Mg 1.8
-PCR 41.1
-Na 123 K 5 Cl 93
-Leu 6900 Hb 9.4 Plaq 267000 Seg 75 VHS 120
-INR 1.24 TTPK 33
-Hb glic 5.9
-RPR N/R
-TSH 4.542 T4L 0.98
-B12 998 Folato 36
-Procalcitonina 0.49

7/10/24 HHM
-Urocultivo(-) OC GB 5-10 GR 10-25 Bact++
-Crea 9.18 MDRD 6 Uremia 118.3
-PCR 55.6
-Na 131 K 4.6 Cl 99
-Hb 9 Leu 11110 Plaq 322000
-INR 2.93 TTPK 31.2
-Hep B y C(-)

OBSERVACIONES:

Ex fco gral:
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RR 2T s/s
-Pulmonar: MP(+) roncus bilaterales escasos, sin uso de musculatura accesoria
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos pedios no palpables, llene N, amputación hallux derecho, catéter HD femoral derecho in situ

Ex neurológico:
-Mental: vigil, afasia fluente, no repite ni nomina, sigue órdenes de 1 paso inconsistentemente, resto n/e
-PC: hemianopsia derecha por amenaza, anisocoria por miosis OI, RFM muy hipoactivo bilateral, MOE N, PFC derecha leve, disartria leve, nistagmo(-), úvula y lengua centrales, resto n/e
-Motor: fuerza ESD M4-M4(+), resto impresiona M5, RCP extensor izquierdo
-Sensitivo: algesia impresiona conservada en fascie y 4 EE
-Cerebelo: n/e
-Signos meningeos(-)
-GCS (O 4, V 4, M 6): 14

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO